随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

心尖部收缩期杂音一般全选，一般缩心炎不选

4.心尖收缩期杂音的可能性 乳头肌功能失调/断裂→二尖瓣脱垂

有杂音也应该是心尖部舒张期杂音

①风湿病、感染性心内膜炎、心梗等致二闭

②左心扩大：如左心衰、扩心病、心肌炎、严重贫血 回心血量↑把左心撑大 门框变大导致相对性关闭不全

③左心肥大：如高血压、肥心病（SAM现象）、主狭（有些老年人可在心尖最清楚） 高血压早期虽然没有左心扩大，但乳头肌肥厚也会导致瓣膜相对性关闭不全

④限心病 毛细血管密度↓→乳头肌缺血→腱索不能拉住二尖瓣→关闭不全

双心房扩大→相对性瓣膜关闭不全

5.胸骨右缘 2 肋间收缩期杂音的可能性：①器质性主狭；②严重主闭 血液反流左室→左心室血↑→射血↑→相对性主狭

主动脉瓣第一听诊区

### （五）胸骨左缘 3-4 肋间听诊

| | |
|---|---|
| 舒张期杂音 | **主闭** |
| 收缩期杂音 | **肥心病** 左心室流出道梗阻<br>**急性心梗并发室间隔穿孔破裂** 左室血液不仅往主动脉射，还通过缺损的室间隔到右室<br>**先天性室缺（警惕亚心炎）** |
| 搔刮音（心包摩擦音） | 急性纤维蛋白性心包炎（如**急性非特异性心包炎、急性心梗**） |
| 舒张期额外心音/附加心音（心包叩击音） | **缩窄性心包炎**（主要）、心包积液 ①心肌细胞坏死→产生自身免疫→心包摩擦音 ②心梗后Dressler综合征也会有心包摩擦音 |

### （六）心室大

心界向左扩大/心尖搏动向左移位既可以是左室大又可以是右室大

| | | |
|---|---|---|
| **左**室大 | 二闭、主狭、主闭、高血压等 | 心**尖**抬举样搏动、心**尖**搏动弥散<br>心尖搏动多向**左下**移位、心界多向**左下**扩大 |
| **右**室大 | 肺心病、二狭等 | 心**前**区/**剑突下**抬举样搏动、心前区/剑突下搏动弥散<br>心尖搏动多向**左**移位、心界多向**左**扩大、**负**性心尖搏动 |

顺钟位转向/心包明显粘连

### （七）脉搏

脉压正常30-40 脉压=收缩压-舒张压

1.**脉压显著增大**（老高闭闭闭）

①老年动脉硬化 动脉粥样硬化(损耗中大动脉)导致弹性储器作用↓→收缩压↑,舒张压↓

②高排量心衰：动静脉瘘、脚气病、严重贫血、甲亢、围生期心肌病（动脚评价人）

③主动脉瓣关闭不全 血液向外周流+反流回左心室→存在主动脉血↓→舒张压显著↓

④严重二闭（慢性重度二闭和急性二闭）往主动脉射血很快结束→收缩期明显↓→舒张期明显↑→舒张期回血+主动脉不断向外周流血→存在主动脉血↓→舒张压显著↓

⑤动脉导管未闭

主动脉血往肺动脉内分流→主动脉血↓




2.常考脉搏特点

| **脉搏短绌** | **P＜心率** | **房颤** |
|---|---|---|
| 水冲脉 | 脉搏骤起骤落 | 甲亢、慢性主闭等 周围血管征:双枪波冲头 |
| 交替脉 | 脉搏强弱交替 | 左心衰代偿时左心收缩提高射血多 |
| **奇脉（吸停脉）** | **吸气时脉搏显著减弱甚至消失；超声心动图室间隔抖动征/吸气时室间隔左移** | 严重的右心衰、心包积液/**心脏压塞**、缩窄性心包炎、**支气管哮喘**、COPD、胸膜疾病（大量胸腔积液、张力性气胸）（C 魔小说包邮） |

### （八）超声心动图

**心肌病**、**瓣膜病**、**心包疾病**（确诊积液性质/病因诊断→心包穿刺）、**急性心梗并发乳头肌功能失调或断裂/室壁瘤/心脏破裂如室间隔破裂/心梗后 Dressler 综合征**、反应**心功能首选**、**感染性心内膜炎**（血培养是首选和金标准）